Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

RAPPORT QUALITÉ

Campagne qualité 2025 réalisée au titre de la période 2023 à 2025

SOMMAIRE



1. **NOTRE HISTOIRE** 03

2. **NOTRE ÉQUIPE** 03

3. **LA SOLUTION DOCS ON THE ROAD** 04

4. **LA MISE EN OEUVRE DE LA SOLUTION** 06

5. **LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOLUTION PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ** 08

6. **DOCS ON THE ROAD AUJOURD'HUI** 09

7. **L'ÉVALUATION DE NOTRE ACTIVITÉ ET NOS OBJECTIFS CIBLES** 11

8. **NOTRE MÉTHODE D'ÉVALUATION** 12
   - 8.1 Les catégories d'impacts et leurs indicateurs
   - 8.2 Le recueil de données
   - 8.3 La feuille de route

9. **RETOUR SUR LES ENTRETIENS ET LEURS RÉSULTATS** 16
   - 9.1 Les entretiens réalisés
   - 9.2 Les résultats des entretiens
     - 9.2.1 Les impacts sur l'accès à la santé
     - 9.2.2 Les impacts fonctionnels
     - 9.2.3 Les impacts organisationnels
     - 9.2.4 Les impacts sur la qualité et la sécurité des soins

10. **NOS AXES D'AMÉLIORATIONS** 28
    - 10.1 L'impact sur l'accès à la santé
    - 10.2 Les impacts fonctionnels
    - 10.3 Les impacts organisationnels
    - 10.4 Les impacts sur la qualité et la sécurité des soins

11. **PLAN D'ACTION** 33

1. NOTRE HISTOIRE

Créé en 2020, pour répondre aux besoins en téléconsultations assistées des établissements et services médico-sociaux, le groupe Docs On The Road est aujourd'hui reconnu pour son expertise en téléconsultations assistées sur le secteur médico-social.

2. NOTRE ÉQUIPE

Notre équipe accompagne aujourd'hui 171 établissements et services du secteur médico-social répartis sur toutes les régions du territoire national et représenté par 102 associations gestionnaires et/ou services publics territoriaux au bénéfice d'environ 8500 personnes accompagnées.



3. LA SOLUTION DOCS ON THE ROAD

ALLIANCE DU DIGITAL ET DE L'HUMAIN



LES AVANTAGES DE LA SOLUTION :

- Apporte le lien humain
- Facilite l'usage du numérique
- Anticipe les complications
- Optimise les coûts de transport et logistique
- Assure la continuité des soins
- Supprime la pénibilité des transports
- Améliore l'observance du patient
- Permet le maintien au domicile en toute sécurité



ÉQUIPE MÉDICALE ET PARA-MÉDICALE



Eudes MENAGER
Directeur médical



Cédric VILLEMINOT
Directeur médical adjoint

MÉDECINE PHYSIQUE DE RÉADAPTATION



Sabine BAPTISTE



Méda TODOR

MÉDECINE GÉNÉRALE - GÉRIATRIE - MÉDECINE DE COORDINATION



Bathilde LECLAIR



Hasina RAZAFINDRALAMBO



Alessandro CARINI



Ons LARIBI



Yasmine TAIEB



Sandra TOUATI



Catherine JUTARD



Hélène DEVAUX



Patricia SARRAIL



Fatima RAHAL



Raymond CHAPERON



Véronique GUYOMARD

PSYCHIATRIE-PÉDOPSYCHIATRIE



Emmanuel DUPONT



Didier TOUZEAU



Maxime ELIE



Daniel COHEN



Jean HARBONNIER



Martine GARREAU



Ephrem MÉNAGER



Dorina CRISTEA



Pascaline GUERIN

ORTHOPHONISTE

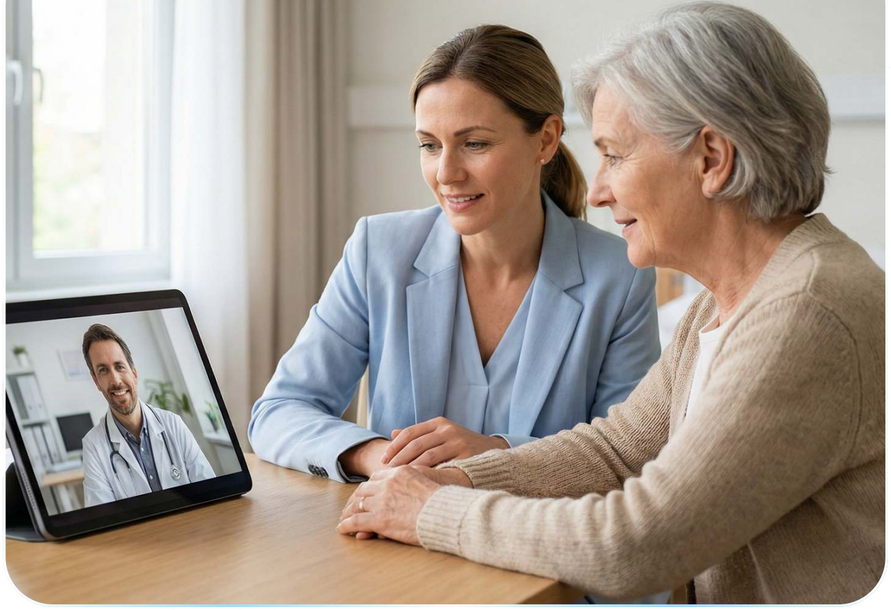


Sophie CHRISTOL

Vision Moderne de la Santé

4. LA MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION





LA TÉLÉCONSULTATION ASSISTÉE

L'INFIRMIER(E)

- Apporte de l'empathie
- Installe le patient dans les meilleures conditions
- Réalise un bilan préliminaire
- Gère les problèmes de transmission numérique
- Permet un examen physique médical complet en collaboration avec le médecin
- Peut expliciter la prise de décision au patient

LE PATIENT

- Est rassuré par une présence humaine
- Participe à l'examen
- Échange avec les professionnels de santé
- Est déchargé des procédures numériques
- Ne se déplace pas

LE MÉDECIN

- Dispose d'un temps médical plus long
- Est informé des données cliniques en amont
- Peut faire réaliser un examen physique complet
- Explicite la prise de décision au patient
- Peut effectuer une e-prescription
- Peut coordonner un parcours de soins

BRANCHES D’INTERVENTIONS

- Les séquences de téléconsultations programmées
- Les téléconsultations non-programmées avec réponse entre 24 et 72h
- Les visites 360 en distanciel et en présentiel (prévention, suivi parcours de soins)
- Les réunions pluriprofessionnelles



LE BILAN 360° POUR UN PROGRAMME DE PRÉVENTION PÉRIODIQUE

- Consultation de médecine générale
- Examen cardio-respiratoire
- Médecine physique et de réadaptation
- Examen bucco-dentaire
- Examen ORL
- Consultation de dermatologie
- Bilan biologique
- Santé mentale
- Synthèse des résultats



5. LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOLUTION PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ

Prestation médicale / Paramédicale	2023	2024	2025
Médecine générale	27	43	59
Médecine de coordination	1	10	24
Psychiatrie/ Pédopsychiatrie	27	43	55
MPR	7	9	12
Orthophonie			1

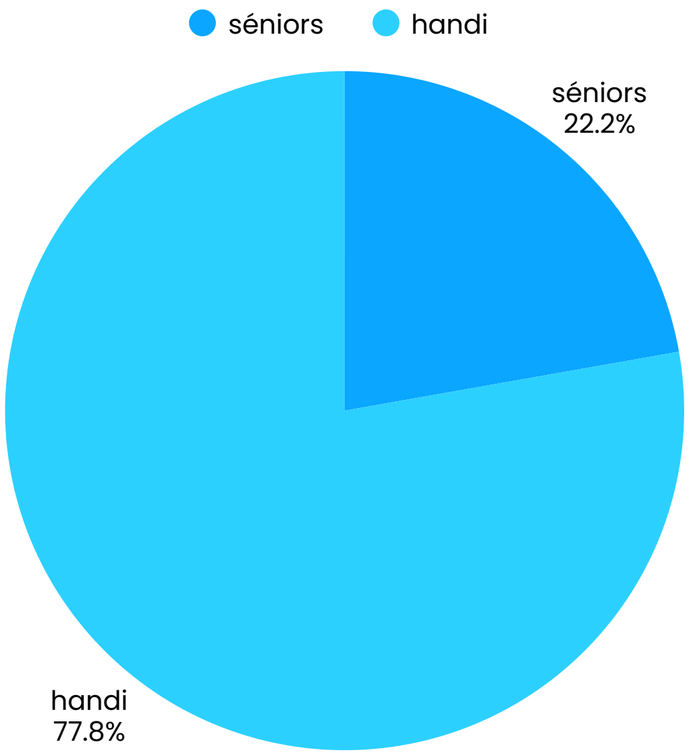
SECTEUR HANDICAP
IME, EEAP, ITEP, SESSAD, FAM, MAS, SAMSAH

Prestation médicale / Paramédicale	2023	2024	2025
Médecine générale	9	10	15
Médecine de coordination	2	13	23
Psychiatrie		1	1

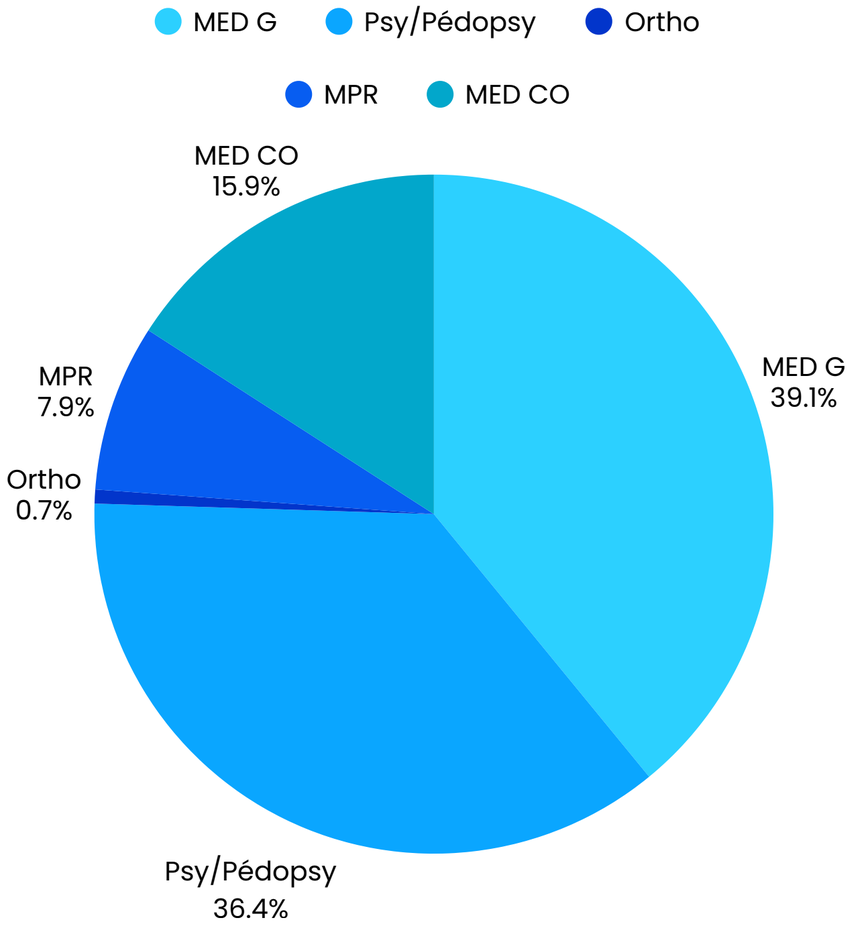
SECTEUR SÉNIORS
EHPAD, RÉSIDENCES SÉNIORS

6. DOCS ON THE ROAD AUJOURD'HUI

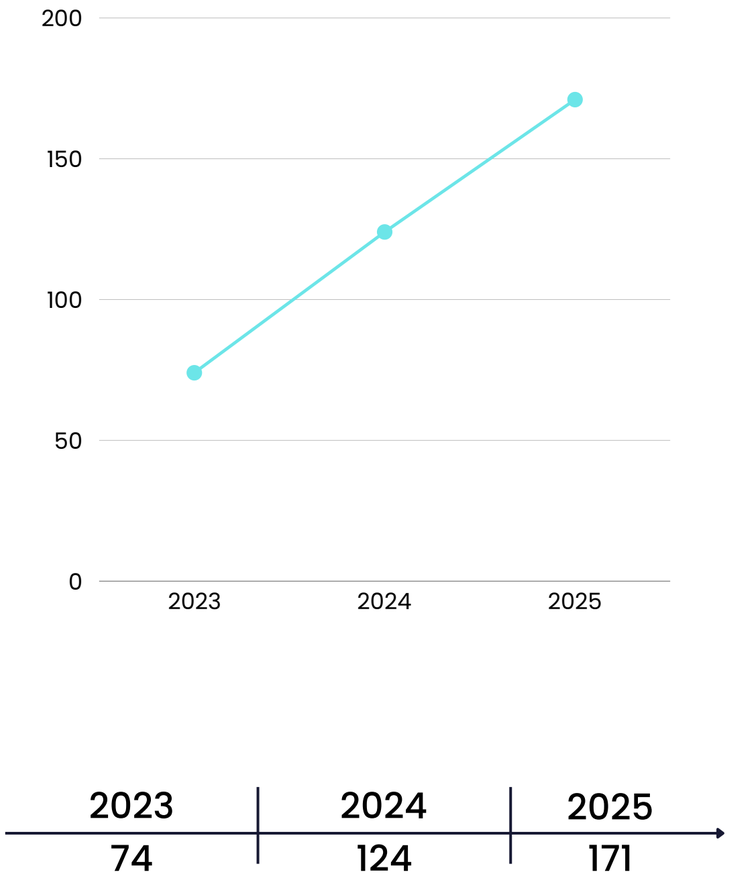
RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE D'ÉTABLISSEMENTS ET DE SERVICES DÉCEMBRE 2025



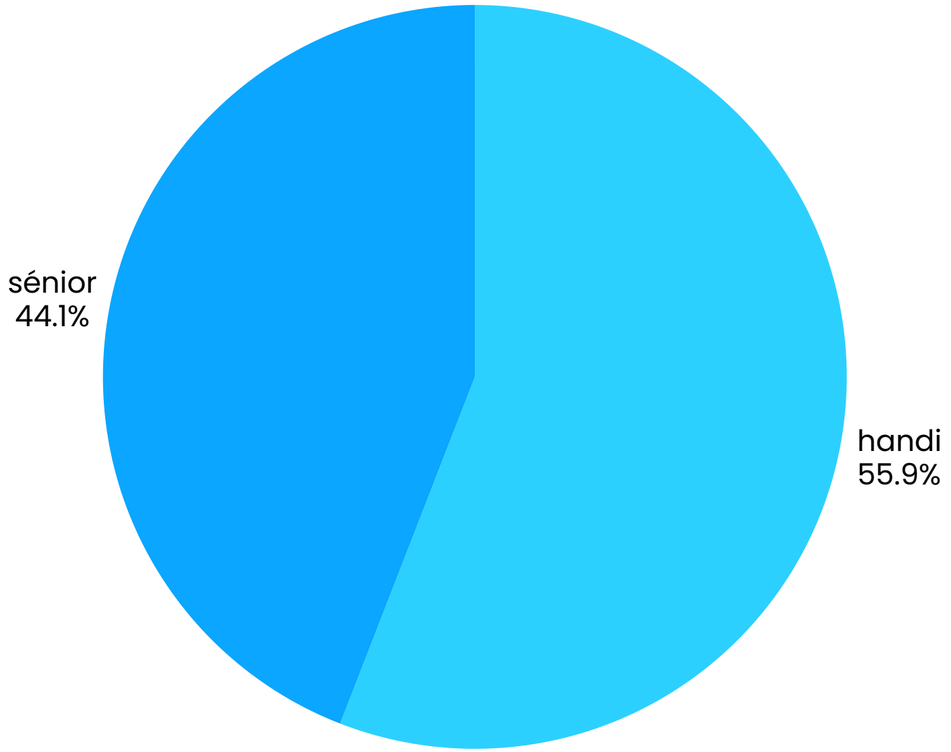
RÉPARTITION DE L'OFFRE DE SERVICE PAR SPÉCIALITÉS REQUISES DÉCEMBRE 2025



Évolution de l’offre de service : nombre de prestations en file active sur les deux secteurs d’activité



Volume temps-couverture médicale mensuelle par secteur



SECTEUR HANDICAP	916h / MOIS
SECTEUR SÉNIOR	770h / MOIS

7. L'ÉVALUATION DE NOTRE ACTIVITÉ ET NOS OBJECTIFS CIBLES

Après cinq années de développement visant à promouvoir une solution innovante en réponse aux besoins du secteur médico-social pour garantir la continuité des soins médicaux depuis un exercice coordonné entre les médecins référents et les équipes soignantes, Docs On The Road formalise aujourd'hui sa démarche d'évaluation et de mesure d'impact.



NOS OBJECTIFS CIBLES :

- **VALORISER LE DISPOSITIF AUPRÈS DES UTILISATEURS**

→ *Formaliser les retours d'expérience et témoignages des utilisateurs pour mieux démontrer la valeur ajoutée du dispositif.*

- **CONSOLIDER LA STRUCTURE DE NOTRE SUIVI COMMERCIAL**

→ *Mettre en place un système de suivi des interactions entre les commerciaux et leurs clients afin d'améliorer la traçabilité et la satisfaction des utilisateurs.*

- **IDENTIFIER LES AXES D'AMÉLIORATION**

→ *Définir et prioriser les points d'amélioration à partir des retours externes, dans une logique d'amélioration continue.*

- **INTÉGRER LA DÉMARCHE QUALITÉ DANS L'ENSEMBLE DU DISPOSITIF**

→ *Implémenter les principes de la qualité (planification, mise en oeuvre, évaluation, mesures correctives) dans tous les processus de développement, déploiement et support.*

- **CAPITALISER SUR L'EXPÉRIENCE ET LES COMPÉTENCES INTERNES**

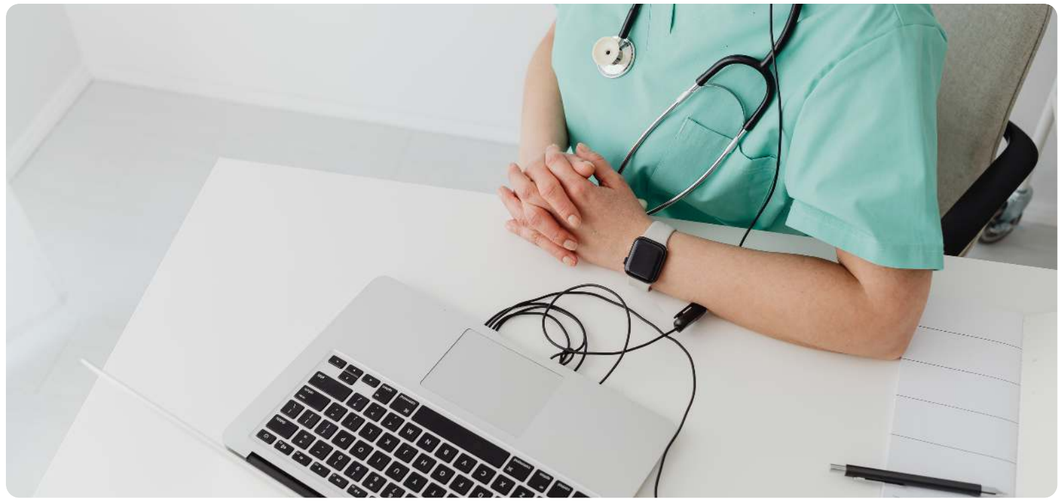
→ *Formaliser et documenter les savoir-faire, méthodes et bonnes pratiques afin de garantir la pérennité et le partage des connaissances au sein de l'équipe.*

8. NOTRE MÉTHODE D'ÉVALUATION

DE L'EXPÉRIENCE PATIENT À L'EXPÉRIENCE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICE : UNE MÊME EXIGENCE D'ATTENTION ET DE QUALITÉ

« L'expérience patient est la perception qu'ont les patients de leur vécu tout au long de leur parcours de soin. Elle est influencée par l'ensemble des personnes impliquées et par l'environnement de prise en charge ».

« L'expérience des ESMS est l'ensemble des perceptions et émotions que notre organisation procure aux établissements et services lorsqu'ils entrent en contact avec nous. Cela englobe la qualité de notre offre de produit et de service mais aussi la qualité de la relation et de l'accompagnement ».



MÉTHODOLOGIE CHOISIE :

ÉVALUATION QUALITATIVE RÉALISÉE DEPUIS L'EXPÉRIENCE DES UTILISATEURS

PUBLIC CIBLE
Les utilisateurs directs de la solution exerçant en établissements et services médico-sociaux

STRATÉGIE D'ÉCHANTILLONNAGE
Échantillonnage stratifié (type d'activité, de public, implantation géographique) et par quotas auprès des utilisateurs des trois secteurs d'activité couverts dans le cadre du déploiement de la solution

RECUEIL DE DONNÉES
30 % d'entretiens directs répartis sur les deux secteurs d'activité couverts (secteur handicap et secteur senior). Recueil de données individualisé sur 40 séquences de 30 minutes (entretiens semi-directifs).

OUTIL DE RECUEIL DE DONNÉES
Cartographie du parcours utilisateur, grille d'entretien

ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES
Données qualitatives (arbre d'analyse) et quantitatives (pourcentages et scores)

CALENDRIER
Déploiement de la démarche sur les mois de novembre 2025 à janvier 2026

LIVRABLES ATTENDUS
Rapport d'évaluation, plan d'amélioration continue de la qualité, livret qualité, complément verbatims et témoignages.

8.1 LES CATÉGORIES D'IMPACTS CIBLES ET LEURS INDICATEURS

CATÉGORIE D'IMPACT	CE QU'ELLE REGROUPE	INDICATEUR RETENU	CRITÈRE DE L'INDICATEUR
LES IMPACTS SUR L'ACCÈS À LA SANTÉ	Concernent les réponses apportées par la solution au regard du contexte de risque de rupture des soins médicaux pour les personnes accompagnées par les établissements et services médico-sociaux	1. Part des établissements en rupture de continuité de l'accès aux soins ayant obtenu une solution avec le dispositif 2. Niveau d'adhésion à la présentation de la solution au regard des besoins	1. % avec temporalité 2. Score 1 à 3 avec temporalité
LES IMPACTS FONCTIONNELS	Ils regroupent l'ensemble des éléments relatifs à l'installation de la solution in situ, à l'accompagnement des utilisateurs pour la bonne prise en main des outils, au suivi technique au quotidien	1. Niveau de facilité de prise en main des outils 2. Niveau de satisfaction des réponses aux besoins techniques	1. Score 1 à 5 2. %
LES IMPACTS ORGANISATIONNELS	Ils incluent les différents domaines organisationnels pouvant être consolidés par la mise en place de la solution	1. Niveau de couverture des besoins renforcée par la solution 2. Part de plus-value organisationnelle apportée par la solution 3. Niveau de consolidation des outils et process référentiels réglementaires	1. % 2. % 3. %
LES IMPACTS SUR LA QUALITÉ ET LA CONTINUITÉ DES SOINS	Concerne les moyens déployés pour renforcer l'offre de continuité et de qualité des soins apportés pour les bénéficiaires	1. Part des éléments qualitatifs (plus-value) apportée par la solution en matière de qualité et continuité des soins 2. Nombre de professionnels ayant développé leurs compétences dans le cadre de la mise en place de la solution	1. % 2. % sur public cible

8.2 LE RECUEIL DE DONNÉES

LE TRAITEMENT DES DONNÉES ET LE RAPPORT

LA MÉTHODE DE COLLECTE

- EST RÉALISÉE SUR LA BASE DE 40 ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS
- S'APPUIE SUR LE PARCOURS DES ESMS LORS DE LA MISE EN PLACE DE LA SOLUTION PUIS AU COURS DE SON UTILISATION

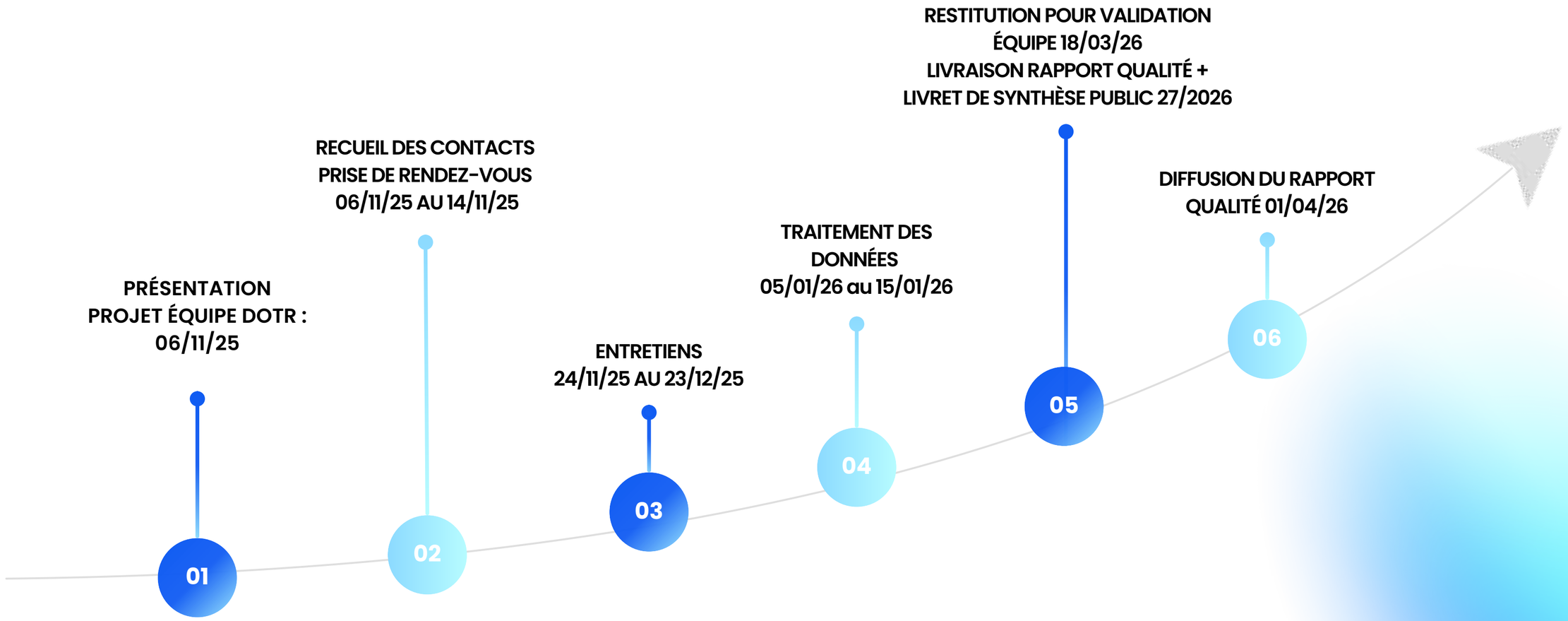
LES DONNÉES QUANTITATIVES + **LES DONNÉES QUALITATIVES** =

RAPPORT QUALITÉ



8.3 FEUILLE DE ROUTE

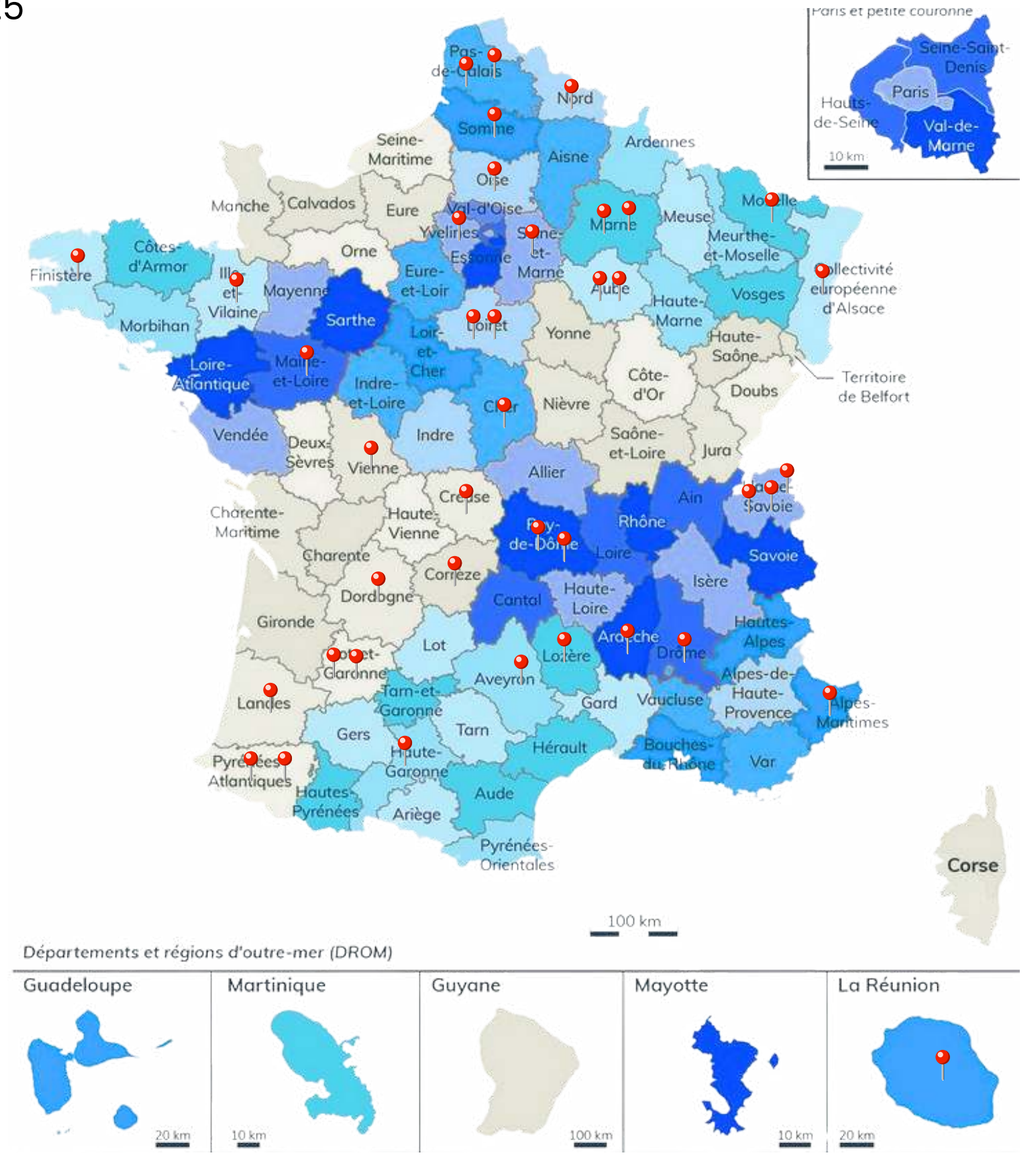
L'EXPÉRIENCE DES ESMS
AU SERVICE DE NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ



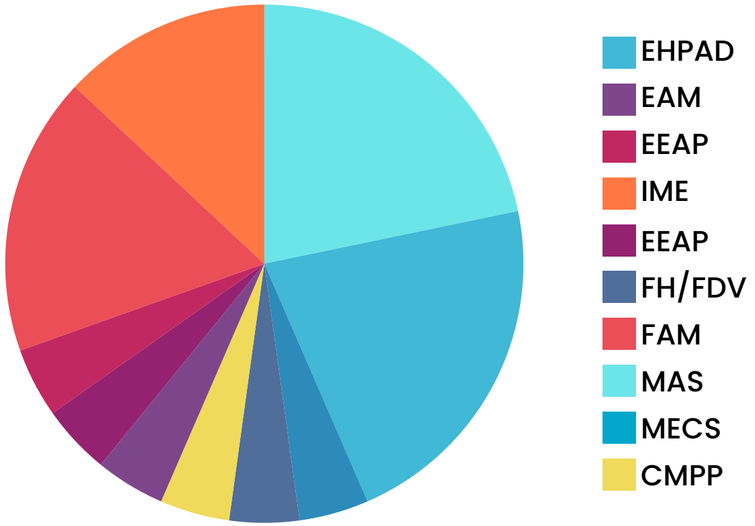
9. RETOUR SUR LES ENTRETIENS ET LEURS RÉSULTATS

9.1 LES ENTRETIENS RÉALISÉS

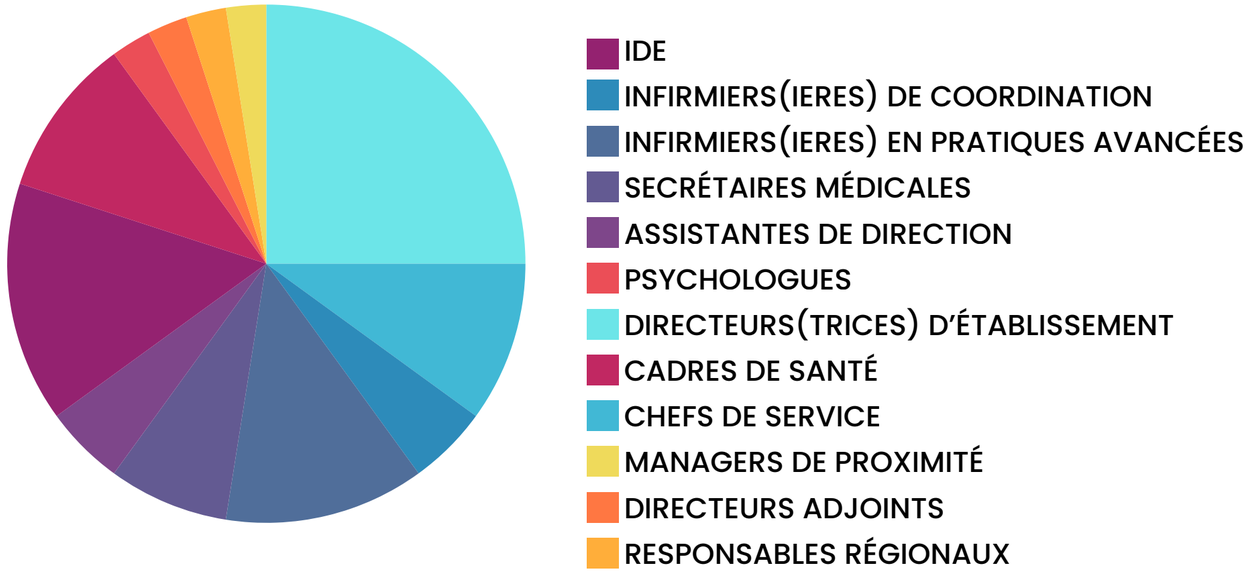
24/11/2025 AU 22/12/2025



LES DIFFÉRENTS TYPES D'ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS



LES DIFFÉRENTS PROFESSIONNELS PARTICIPANTS



1. PART DES ÉTABLISSEMENTS EN RUPTURE DE CONTINUITÉ DE L'ACCÈS AUX SOINS AYANT OBTENU UNE SOLUTION AVEC LE DISPOSITIF

9.2 LES RÉSULTATS DES ENTRETIENS

9.2.1 Les impacts sur l'accès à la santé

ENVIRON 92% DES PARTICIPANTS ÉTAIENT EN SITUATION DE RUPTURE DE SOINS MÉDICAUX AVANT LA MISE EN PLACE DE LA SOLUTION, CARACTÉRISÉE PAR UNE ABSENCE PROLONGÉE DE MÉDECIN OU UNE CONTINUITÉ DES SOINS INSUFFISANTE.

CONSTATS

- Départs en retraite ou démissions non remplacés
- Impossibilité de recruter
- Recours à l'intérim ou aux vacataires
- Territoires sous-dotés ou ruraux isolés
- Des résidents sans médecin pendant 1 à 2 ans, parfois plus
- Augmentation des hospitalisations, notamment lors de changements de traitement
- Ruptures de parcours de soins, difficultés de prévention
- Problèmes récurrents de renouvellement d'ordonnances, de prescriptions et de sécurisation du circuit du médicament
- Charge accrue pour les équipes et difficultés de continuité des soins sans cadre médical stable

ANALYSE

Ont été considérées en rupture de soins médicaux les situations où il est fait mention de :

- Absence totale de médecin (généraliste, psychiatre, coordinateur)
- Absence de suivi médical structuré
- Impossibilité de renouveler les prescriptions
- Recours exclusif à l'intérim ou à des vacataires sans continuité
- Durées prolongées sans médecin (plusieurs mois)
- La rupture de soins est quasi systémique dans les situations décrites

Les rares cas non qualifiés de rupture complète correspondent à :

- Une couverture partielle
- Des pratiques déjà existantes en visio
- Un suivi très dégradé mais non totalement interrompu (recours exclusif à l'intérim ou à des vacataires sans continuité)

« On ne veut pas changer de système c'est du vrai travail »

CHEF DE SERVICE SECTEUR SÉNIORS

« J'espère que ça va continuer vu le contexte dans la région »

INFIRMIÈRE - SECTEUR HANDICAP

EN CONCLUSION

- La solution a permis de rétablir une continuité effective des soins dans certains territoires durablement confrontés à la pénurie médicale
- Le déploiement du dispositif s'inscrit comme un levier opérationnel de politique publique, en apportant une réponse concrète à une rupture de soins touchant près de 92 % des établissements participants accompagnés aujourd'hui par DOTR

LE NIVEAU D'ADHÉSION DES PARTIES PRENANTES À LA MISE EN PLACE DE LA SOLUTION CORRESPOND À UN SCORE MOYEN PONDÉRÉ DE 2,5 / 3 TRADUISANT UNE ADHÉSION GLOBALEMENT FORTE MAIS ACQUISE PROGRESSIVEMENT.

CONSTATS

Réticences fréquentes au démarrage, liées :

- À la télémédecine et aux nouvelles technologies
- Au changement de pratiques professionnelles
- À la crainte d'un suivi médical insuffisant ou inadapté au public accompagné

Dans la majorité des cas, l'adhésion devient **bonne à très bonne après quelques mois**.

Plusieurs témoignages soulignent :

- Un **bilan très positif après 6 mois**
- Une volonté affirmée de **ne plus revenir à l'ancien système**
- Des équipes et des familles qui **insistent pour conserver le médecin** impliqué

Les usagers (enfants, adultes, familles) sont globalement **partants**, avec parfois un besoin d'accompagnement renforcé selon les profils.

ANALYSE

AU DÉMARRAGE : ADHÉSION PLUTÔT FAIBLE À MODÉRÉE

De nombreux témoignages évoquent :

- Des craintes liées à la télémédecine
- Des freins culturels et organisationnels
- Des difficultés avec les familles et certains professionnels

Cela correspondrait initialement à un **score proche de 1,5 / 3**.

Après mise en œuvre et stabilisation : adhésion élevée

La majorité des établissements rapportent :

- Une amélioration nette du suivi médical
- Une collaboration fluide avec le médecin
- Une satisfaction forte des équipes
- Une volonté de **ne pas changer de système**
- Une bonne adhésion des personnes accompagnées et des familles après information
- La nécessité d'une réelle démarche de communication auprès des familles et des équipes
- L'indispensable pilotage en interne du dispositif
- La mutualisation inter-établissements comme levier d'adhésion

Cela correspondrait à un **score de 3 / 3** à moyen terme.

Pondération globale

- Les réticences initiales sont fréquentes mais **transitoires**
- Les retours négatifs persistants sont **minoritaires**
- Le ressenti final est très majoritairement **positif**

«On a eu beaucoup de freins même pour récupérer les consentements »

DIRECTRICE - SECTEUR HANDICAP

« On a fait Beaucoup de communication avec les instances, et les professionnels de terrain pour montrer la plus value de ces nouvelles méthodes de collaboration »

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ - SECTEUR SÉNIORS

« Le médecin a gagné la confiance des professionnels »

RESPONSABLE DE PÔLE - SECTEUR HANDICAP

« On avait une exigence ressentie des deux cotés, déploiement finalement très fluide malgré les craintes mais ca roule !! »

CHEF DE SERVICE - SECTEUR HANDICAP

EN CONCLUSION

Le score reflète une adhésion consolidée, à condition que la mise en place de la solution soit accompagnée, expliquée et pilotée.

9.2 LES RÉSULTATS DES ENTRETIENS

9.2.2 Les impacts fonctionnels

LE SCORE GLOBAL EST DE 3,9 /5 CE QUI TRADUIT UNE BONNE FACILITÉ DE PRISE EN MAIN, PÉNALISÉE PRINCIPALEMENT PAR LES CONDITIONS DE DÉPLOIEMENT ET DE FORMATION, PLUS QUE PAR LA QUALITÉ INTRINSÈQUE DES OUTILS.

CONSTATS

Éléments positifs majoritaires :

- Nombreux retours indiquant une bonne prise en main après un temps d'adaptation
- Plateforme jugée ludique, ergonomique, fluide une fois maîtrisée
- Outils connectés perçus comme pratiques et qualitatifs, avec une bonne adhésion des équipes formées

ANALYSE

Difficultés au démarrage récurrentes :

- Plateforme pas toujours intuitive au départ
- Accès aux logiciels métiers parfois tardifs (accès donné par les établissements)
- Appropriation plus longue pour certains profils

Problématiques DE Turn-over des professionnels (intérimaires, remplaçants)

- Niveau d'aisance informatique variable selon les utilisateurs

DEMANDES

Des formations répétées, des supports pédagogiques complémentaires (tutos, fiches)

« Les infirmières intérimaires ne sont pas forcément formées sur les outils, il faudrait prévoir un support plateforme et outils pour formations »

SECRÉTAIRE MÉDICALE - SECTEUR SÉNIORS

« Avec le médecin psychiatre DOTR on a pas vraiment besoin des outils connectés, mais on les utilise pour la médecine générale locale »

INFIRMIÈRE COORDINATRICE - SECTEUR HANDICAP

« On a eu rapidement une bonne prise en main de la plateforme et des outils connectés du sac à dos »

CHEF DE SERVICE - SECTEUR HANDICAP

EN CONCLUSION

La facilité de prise en main des outils techniques est globalement satisfaisante, avec une appropriation rapide après un temps d'adaptation et un besoin identifié de formation et de supports complémentaires, notamment en contexte de turn-over des équipes.

ENVIRON 88% DES PARTICIPANTS ESTIMENT QUE LA SOLUTION RÉPOND DE MANIÈRE SATISFAISANTE À LEURS BESOINS TECHNIQUES, TANT SUR LE PLAN FONCTIONNEL QUE CLINIQUE. LES ATTENTES EXPRIMÉES CONCERNENT PRINCIPALEMENT DES ÉVOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES PLUTÔT QU'UNE REMISE EN QUESTION DE LA SOLUTION.

CONSTATS

Les délais de réponse sont jugés **rapides à immédiats**, avec un support décrit comme **disponible, efficace et à l'écoute**.
L'accompagnement du **responsable régional** et la coordination avec les professionnels médicaux ont joué un rôle clé dans la réussite du déploiement.
Les **difficultés rencontrées au démarrage** (organisation, accès techniques, appropriation des outils) ont été **rapidement prises en charge**, permettant une stabilisation satisfaisante de l'usage.

La réactivité des équipes (support technique, staff DOTR, responsable régional) est très largement soulignée comme un **point fort majeur**.
Les réponses sont décrites comme **rapides, immédiates et efficaces** : *« action–réaction »*, *« ils répondent tout de suite »*, *« hyper réactif »*, *« planning impeccable »*.

L'accompagnement humain est central :
Forte disponibilité du **responsable régional** (sensibilisation des équipes, coordination, suivi), **bonne coordination avec les médecins**, facilitant une mise en œuvre plus rapide.
Malgré des **difficultés initiales** (accès aux logiciels métier, problèmes techniques, organisation à adapter), les situations ont été **résolues progressivement**, avec un ressenti final positif.

ANALYSE

- Une très large majorité des participants considèrent que la solution répond efficacement à leurs besoins techniques et fonctionnels.
- Les outils sont jugés pertinents, qualitatifs et utiles dans les pratiques professionnelles, avec une valeur ajoutée clinique reconnue.
- Les participants expriment un sentiment d'écoute et de prise en compte de leurs contraintes, renforçant l'adhésion au projet
- Les besoins d'amélioration évoqués portent principalement sur des évolutions complémentaires (interopérabilité, équipements spécifiques, formation continue), et non sur des insuffisances de la solution

« Au départ on a pataugé un peu avec le médecin mais ça c'est bien passé, l'infirmière coordinatrice DOTR nous a beaucoup aidé ».

CHEF DE SERVICE PARAMÉDICALE - SECTEUR HANDICAP

« L'assistance technique s'est toujours bien passée, on a un très bon accueil et des solutions, l'aide technique est très efficace »

INFIRMIER EN PRATIQUES AVANCÉES - SECTEUR HANDICAP

« Au début ce n'était pas évident la plateforme et l'accès à notre logiciel de soin (Titan) maintenant le médecin peut rentré direct dans le logiciel »

CADRE DE SANTÉ - SECTEUR SÉNIORS

«Plateforme très ludique, on a vraiment des personnes en face qui sont dispos »

CHEF DE SERVICE - SECTEUR HANDICAP

EN CONCLUSION

La réactivité constitue un levier majeur de réussite du projet et un point fort unanimement reconnu par les participants.
Elle apporte une réponse très satisfaisante aux besoins techniques, avec un fort niveau de confiance et de satisfaction des utilisateurs.

9.2 LES RÉSULTATS DES ENTRETIENS

9.2.3 Les impacts Organisationnels

LA COUVERTURE MÉDICALE EST L'AXE LE PLUS MASSIVEMENT CITÉ SOIT PAR 90% DES PARTICIPANTS, SOUVENT PRÉSENTÉ COMME UN BESOIN INITIAL CRITIQUE DÉSORMAIS COMBLÉ.

CONSTATS

Éléments récurrents identifiés :

- Accès effectif à un médecin référent (souvent là où il n'y en avait pas ou peu)
- Renouvellements de prescriptions, ajustements thérapeutiques
- Suivi des pathologies chroniques, situations complexes, avis spécialisés
- Réduction des hospitalisations et du recours aux urgences
- Continuité des soins (présentiel + distanciel)

Les interventions médicales couvrent des champs variés : médecine générale, gériatrie, psychiatrie, MPR, pédiatrie, rééducation, nutrition, prévention (vaccination, canicule), avec une expertise adaptée aux profils des personnes accompagnées.

Les temps de présentiel ponctuels renforcent la pertinence des suivis à distance en permettant une connaissance clinique directe des résidents.

La solution apporte une **réponse large, continue et sécurisante aux besoins médicaux**, notamment au regard de la complexité des situations et de la diversité des publics accompagnés.

La solution permet d'assurer un **suivi médical régulier**, notamment pour les pathologies chroniques, les situations non urgentes, les renouvellements de prescriptions et les ajustements thérapeutiques.

Elle contribue à une **réduction du recours aux urgences et des hospitalisations**, avec un impact direct sur la qualité de prise en charge des résidents.

ANALYSE

La mise en œuvre de la solution s'accompagne d'une **organisation structurée, co-construite avec les équipes**, favorisant l'efficience et la coordination :

- **Structuration des temps médicaux** : créneaux fixes, séquences dédiées, temps de coordination en amont et débriefings en aval
- **Préparation et priorisation des situations**, parfois via des outils internes (codes couleurs, dossiers préparatoires, regroupement des demandes)
- **Organisation de réunions pluridisciplinaires régulières**, intégrant médecins, infirmiers, paramédicaux et équipes éducatives
- **Articulation fluide entre présentiel et distanciel**, le présentiel renforçant la pertinence des téléconsultations ultérieures
- **Optimisation du temps soignant** : diminution des déplacements, meilleure concentration sur les situations cliniques, gain de temps administratif
- **Renforcement du lien infirmier–médecin**, avec une communication plus directe, professionnelle et orientée solutions

« On l'utilise beaucoup pour les renouvellements d'ordonnances, renouvellements MDPH, et les dossiers de dossier séjours adaptés et au quotidien en fonction des différents symptômes »

MANAGER DE PROXIMITÉ - SECTEUR HANDICAP

« C'est repérant pour tout le monde, ça a répondu à mes exigences : évaluation/ prescription / réévaluation processus, on enlève tous les éléments qui vont venir parasiter »

INFIRMIÈRE COORDINATRICE - SECTEUR HANDICAP

« 60 résidents sans suivi pendant plus d'un an, nos stats démontrent clairement les impacts de l'avis médical , on a moins de recours aux urgences et d'hospitalisations. Les résidents gagnent en qualité de prise en charge"

INFIRMIER EN PRATIQUES AVANCÉES - SECTEUR SÉNIORS

EN CONCLUSION

Au-delà de l'accès aux soins, le dispositif génère une harmonisation organisationnelle : structuration des temps médicaux, meilleure préparation des situations, coordination pluridisciplinaire renforcée et optimisation du temps soignant. La communication entre professionnels s'en trouve fluidifiée, l'articulation entre projet de soins et réalités de terrain clarifiée, et l'efficience globale améliorée.

LES DIFFÉRENTS DOMAINES ORGANISATIONNELS CONSOLIDÉS PAR LA MISE EN PLACE DE LA SOLUTION.

LA COORDINATION DES ACTEURS…
UN IMPACT ÉVOQUÉ PAR 82,5 % DES PARTICIPANTS.

LA SOLUTION EST PERÇUE COMME UN OUTIL STRUCTURANT DE COORDINATION, RÉDUISANT LES RUPTURES ET LES PERTES D'INFORMATION.

CONSTATS

Éléments observés :

- Meilleure articulation infirmiers / médecins / équipes pluridisciplinaires
- Coordination avec médecins traitants et spécialistes
- Réunions pluridisciplinaires structurées
- Co-construction des décisions médicales
- Intégration dans les logiciels métiers et échanges fluidifiés

ANALYSE

La solution structure la **coordination entre infirmiers, médecins (traitants, coordonnateurs, spécialistes) et équipes pluridisciplinaires**, avec des échanges fluides (visio, mails, plateforme).
Elle favorise un **travail collaboratif** avec des temps formalisés : réunions pluridisciplinaires, séquences de coordination, débriefings, allers-retours sur les procédures et situations complexes.
Les liens avec les médecins traitants sont renforcés (courriers médicaux, coordination des prescriptions, continuité des soins).
La solution facilite également l'orientation vers le **réseau territorial**, y compris en situation de crise.

LE SOUTIEN DES ÉQUIPES…
UN IMPACT ÉVOQUÉ PAR 87,5% DES PARTICIPANTS

LE SOUTIEN DES ÉQUIPES RESSORT COMME UN IMPACT HUMAIN ET MANAGÉRIAL MAJEUR, AU-DELÀ DU SEUL APPORT MÉDICAL.

CONSTATS

Éléments soulignés :

- Sentiment de sécurisation professionnelle
- Disponibilité, écoute et posture bienveillante des médecins
- Appui à la prise de décision et à la priorisation
- Montée en compétences des équipes
- Amélioration des conditions de travail (gain de temps, moins de stress)

ANALYSE

Les équipes soignantes expriment un fort sentiment de sécurisation, lié à la disponibilité, l'écoute et la réactivité des médecins.
Le médecin est perçu comme un appui expert : avis médicaux, conduites à tenir, éclairage sur des situations complexes, soutien dans les phases aiguës.
La solution renforce la montée en compétences des équipes, notamment par la réflexion clinique partagée, la priorisation des situations et l'anticipation.
Elle améliore les conditions de travail (gain de temps, diminution des déplacements, meilleure lisibilité des informations, continuité du suivi).

« Ce qui est top pour moi : les mails, l'informatisation , on gagne en efficacité et en rapidité , fluidité ça c'est pas mal ! »

CHEF DE SERVICE - SECTEUR HANDICAP

« C'est chronométré il faut des temps efficaces, efficients, GIR et PATHOS super travail , on s'entend très bien, on a les mêmes valeurs ça match ! Elle nous apporte beaucoup d'éléments, nous tire vers le meilleur »

CHEF DE SERVICE - SECTEUR SÉNIORS

« Pour le suivi administratif c'est génial, on ne court plus après les infos ! Ça m'a permis de rebaliser le lien IDE/ médecin prescripteur »

CHEF DE SERVICE - SECTEUR HANDICAP

«Sur les créneaux, on prévoit toujours un temps de coordination avec les professionnels avant de commencer les téléconsultations et on fait un temps de débriefing »

CHEF DE SERVICE - SECTEUR HANDICAP

EN CONCLUSION

La solution génère une forte plus-value organisationnelle. Elle constitue un véritable levier structurant, réduisant les ruptures de parcours et les pertes d'information grâce à une articulation renforcée entre infirmiers, médecins et équipes pluridisciplinaires. Les décisions co-construites et les temps de coordination formalisés favorisent une continuité des soins plus lisible et efficiente, y compris dans les liens avec le réseau territorial. La solution agit à la fois comme outil de coordination et comme facteur de stabilisation et de professionnalisation des pratiques.

AU REGARD DES RETOURS TERRAIN ET DES USAGES DÉCRITS, QUELLES QUE SOIENT LES SPÉCIALISATIONS MÉDICALES REQUISES, LA SOLUTION PERMET UN NIVEAU DE CONSOLIDATION DES OUTILS ET PROCESS RÉFÉRENTIELS RÉGLEMENTAIRES ESTIMÉ À ENVIRON 82%.

CONSTATS

Les participants rapportent différents points de consolidation apportés par la solution concernant :

- La mise à jour et la création des protocoles réglementaires (douleur, prévention, plan bleu, conduites à tenir, canicule, vaccins, circuit du médicament)
- La sécurisation des prescriptions et renouvellements, souvent cités comme un point critique avant la solution, est explicitement citée comme levier clé de préparation et de consolidations dans le cadre des d'évaluations HAS
- La structuration des process de travail coordonnés (séquences chronométrées, créneaux dédiés, intégration logiciel métier, codes couleurs de priorisation, workflows)
- La réduction des non-conformités organisationnelles (absence de médecin, prescriptions illisibles, défaut de coordination)
- La sécurisation du circuit du médicament, identifié comme un point clé.
- La révision et l'actualisation des protocoles de soins, conduites à tenir, plans spécifiques (douleur, plan bleu, prévention), avec l'appui du médecin.
- La participation active du médecin aux démarches institutionnelles : préparation des évaluations HAS et externes, élaboration et mise à jour des documents réglementaires, contribution au Rapport Annuel d'Activité Médicale (RAMA), appui aux dossiers d'admission, de d'orientation et de renouvellements MDPH.

ANALYSE

Le recueil de données précise que la solution contribue à :

- La formalisation des outils réglementaires 85%
- La sécurisation / conformité (prescriptions, circuit du médicament) 90 %
- La structuration des process médicaux 80 %
- La préparation des évaluations HAS et/ou les outils d'évaluation des besoins GIR-PATHOS 72%

Les 18 % restants correspondent principalement :

- À la spécialisation requise non sollicitée sur les outils et process (ex : médecin psychiatre; MPR)
- À la dépendance partielle au présentiel pour certains actes
- Aux freins humains et culturels dans certains établissements
- À une consolidation encore en cours dans quelques structures récemment déployées

.

La solution agit comme un levier de mise en conformité durable, renforçant la sécurité, la qualité et la robustesse des pratiques professionnelles.

« L'intérêt c'est une vraie lecture sécurisée sur la traçabilité des prescriptions, on est plus dans les clous avec la réglementation, on imagine que c'est mieux en présentiel, mais le système s'est finalement renforcé »

CHEF DE SERVICE - SECTEUR HANDICAP

« On a sollicité le médecin pour actualiser notre plan bleu »

DIRECTEUR - SECTEUR HANDICAP

« C'est toujours un plus de l'avoir pour les protocoles on a tout remis à jour en 2024 »

CADRE DE SANTÉ - SECTEUR SÉNIORS

« Une année d'évaluation HAS pas facile en distanciel mais on a fait un gros travail sur les protocoles, et les documents à formaliser, le médecin co est très investit dans la situation de préparation en plus du quotidien pour les admissions, et soins courants en complément des médecins traitants »

CADRE DE SANTÉ - SECTEUR SÉNIORS

EN CONCLUSION

La solution apporte une réponse très largement validée par les professionnels, avec un impact particulièrement fort sur la couverture médicale et le soutien des équipes, tout en structurant durablement la consolidation des outils et des processus réglementaires.

9.2 LES RÉSULTATS DES ENTRETIENS

9.2.4 Les impacts sur la qualité et la continuité des soins

ENVIRON 90% DES PARTICIPANTS ÉVOQUENT EXPLICITEMENT UNE AMÉLIORATION DE LA CONTINUITÉ ET/OU DE LA QUALITÉ DES SOINS.

CONSTATS

Les participants rapportent différents points qualitatifs apportés par la solution en matière de qualité et de continuité des soins :

- Le format innovant distanciel / présentiel
- L'indispensable de coordination pluridisciplinaire qu'implique la solution
- Une réactivité accrue : prescriptions rapides, ajustements thérapeutiques, suivi rapproché
- Diminution des hospitalisations évitables et des déplacements (résidents, familles, professionnels)
- Une bonne connaissance des patients/résidents par le médecin référent dans le temps
- Des temps médicaux plus courts mais plus qualitatifs, mieux préparés et ciblés
- Intégration réelle du médecin dans les équipes (réunions cliniques, visios, échanges réguliers)
- Une construction collective conduites à tenir et des décisions cliniques
- Un sentiment de sécurité pour les équipes

ANALYSE

Les principales plus-values identifiées :

CONTINUITÉ ET SÉCURISATION DU PARCOURS DE SOINS
- Maintien d'un suivi médical malgré l'absence ou la rareté de médecins sur le territoire (désert médical)
- Réduction des ruptures de soins, y compris en situation d'urgence ou de fragilité

QUALITÉ MÉDICALE RENFORCÉE
- Réévaluation régulière et pertinente des prescriptions (ex : ALD et non ALD)
- Développement d'approches non médicamenteuses et travail sur la prévention

COORDINATION ET TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE
- Travail de coordination avec les familles, partenaires, médecins traitants
- Valorisation de la culture de réunion pluriprofessionnelle

DIMENSION HUMAINE ET RELATIONNELLE
- Relation de confiance durable (médecin référent identifié)
- Reconnaissance mutuelle des expertises (terrain ↔ médical)
- Le distanciel n'est plus perçu comme une contrainte mais comme un levier

1. PART DES ÉLÉMENTS QUALITATIFS (PLUS-VALUE) APPORTÉE PAR LA SOLUTION EN MATIÈRE DE QUALITÉ ET CONTINUITÉ DES SOINS

« il faut apprendre à différer, temporiser ça nous oblige à travailler le réseau en complément, le médecin est mobilisé vraiment sur le temps dédié. Les infirmières mettent vraiment à profit le créneau. C'est une meilleure garantie du suivi et en présentiel on l'a on ne laisse pas passer le temps ! »

CHEF DE SERVICE - SECTEUR HANDICAP

« Le temps est restreint et c'est du temps qualitatif plus que en présentiel »

INFIRMIÈRE COORDINATRICE - SECTEUR SÉNIORS

« J'étais à 150 % je pense que c'est l'avenir ce n'est pas que de la télémédecine mais hybride !! »

DIRECTRICE - SECTEUR HANDICAP

« Aujourd'hui on travail notre PACQ il y a vraiment un suivi, une continuité »

CADRE DE SANTÉ - SECTEUR SÉNIORS

« Ça marche et ce n'est pas une question d'écran mais d'humain ! »

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ - SECTEUR SÉNIORS

EN CONCLUSION

Le dispositif démontre une plus-value majeure sur la continuité et la qualité des soins, particulièrement en contexte de tension démographique médicale. Il contribue à sécuriser les parcours, à réduire les ruptures de soins et les hospitalisations évitables, tout en améliorant la réactivité et la pertinence des prises en charge. Il renforce la qualité médicale par un suivi régulier, une optimisation des prescriptions et le développement d'actions de prévention.

2. PART DES PROFESSIONNELS AYANT DÉVELOPPÉ LEURS COMPÉTENCES DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE LA SOLUTION

ENVIRON 75% DES PARTICIPANTS MENTIONNENT EXPLICITEMENT UN DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES OU UNE ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES APPORTÉ PAR LA SOLUTION.

CONSTATS

Les participants soulignent différents points apportés par la solution en matière de développement de compétences, grâce à :

- Un approfondissement de la connaissance des dossiers et du raisonnement clinique
- Un rôle central : « yeux et oreilles du médecin »
- Une meilleure collaboration interprofessionnelle
- Une intégration durable de nouvelles habitudes de travail non-remises en question
- Un sentiment de sens retrouvé dans les pratiques quotidiennes
- La valorisation et à la reconnaissance des professionnels, renforçant l'engagement des équipes et le sens donné aux pratiques quotidiennes.

ANALYSE

Renforcement des compétences cliniques
- Meilleure capacité d'observation, d'analyse et de transmission clinique
- Participation active aux décisions médicales

Montée en compétences des infirmiers (IDE / IPA)
- Développement de l'autonomie, de l'anticipation et de la priorisation
- Accès à la primo-prescription, ajustements thérapeutiques, suivi renforcé
- Projets de formation avancée (IPA, master)

Évolution des pratiques professionnelles
- Structuration des pratiques (préparation des téléconsultations, plan de soins, suivi)
- Développement d'une culture qualité (PACQ, procédures, analyse des situations complexes)

Valorisation et reconnaissance professionnelle
- Travail infirmier reconnu, valorisé et soutenu par le médecin
- Implication accrue des équipes éducatives et paramédicales

« En réunion du pôle soins avec le médecin, on intègre les équipes dans les échanges sur la santé »

CHEF DE SERVICE - SECTEUR HANDICAP

« Je prépare un master IPA , je m'éclate ce sont des vrais échanges, on est ses yeux et ses oreilles au quotidien »

INFIRMIÈRE - SECTEUR HANDICAP

« C'est vraiment un plus avec ce regard extérieur, le médecin pointe des choses que l'on ne voyait plus du fait de la routine »

INFIRMIÈRE - SECTEUR HANDICAP

« On a défini 26 objectifs de formation pluridisciplinaire avec le médecin ! »

CADRE DE SANTÉ - SECTEUR HANDICAP

« Le médecin s'adapte à l''expertise et au regard du service il y a vraiment une construction collective ! »

CHEF DE SERVICE - SECTEUR HANDICAP

EN CONCLUSION

La solution constitue un levier structurant de montée en compétences et de transformation des pratiques professionnelles. 30 participants sur 40 identifiants un renforcement significatif des compétences cliniques, notamment en matière d'analyse, de raisonnement et de participation aux décisions médicales. Elle favorise l'évolution du rôle infirmier (IDE/IPA), en renforçant l'autonomie, l'anticipation et la coordination des soins. Le dispositif contribue également à la structuration durable des pratiques, au développement de la collaboration interprofessionnelle et à l'installation d'une culture qualité.

10. NOS AXES D'AMÉLIORATION

10.1 LES IMPACTS SUR L'ACCÈS À LA SANTÉ

LA SOLUTION COMME RÉPONSE AUX SITUATIONS DE RUPTURE DE CONTINUITÉ DE L'ACCÈS AUX SOINS

LES ENJEUX

Transformer le dispositif d'une solution opérationnelle ponctuelle en outil stratégique territorial de sécurisation des parcours et de lutte contre les ruptures d'accès aux soins.

AXES D'AMÉLIORATION

→ AFFIRMER LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU DISPOSITIF
→ STRUCTURER LA MUTUALISATION INTER-ÉTABLISSEMENTS

L'ADHÉSION DES ACTEURS À LA MISE EN PLACE DE LA SOLUTION

LES ENJEUX

Passer d'une solution présentée comme innovante à une solution comprise, structurée et collectivement portée par la gouvernance, les équipes et les familles.

AXES D'AMÉLIORATION

→ MIEUX ACCOMPAGNER LES GOUVERNANCES ASSOCIATIVES
→ STRUCTURER L'ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT

10.2 LES IMPACTS FONCTIONNELS

FACILITÉ DE PRISE EN MAIN DES OUTILS

LES ENJEUX

Passer d'un outil perçu comme additionnel à un outil intégré, fluide et à forte valeur clinique dans les pratiques quotidiennes.

AXES D'AMÉLIORATIONS

→ STRUCTURER LA FORMATION ET L'APPROPRIATION DES OUTILS
→ FLUIDIFIER L'INTÉGRATION TECHNIQUE
→ SIMPLIFIER L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR
→ OPTIMISER L'USAGE DES OBJETS CONNECTÉS

LES RÉPONSES AUX BESOINS TECHNIQUES

LES ENJEUX

Passer d'une logique de réaction aux problèmes techniques à une approche anticipée, structurée et sécurisante, garantissant une expérience fluide dès le démarrage.

AXES D'AMÉLIORATIONS

→ RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT ORGANISATIONNEL
→ ANTICIPER LES CONTRAINTES TECHNIQUES LOCALES

10.3 LES IMPACTS ORGANISATIONNELS

COUVERTURE DES BESOINS RENFORCÉE PAR LA SOLUTION

LES ENJEUX

Passer d'un outil de réponse aux tensions médicales à un levier structurant de performance territoriale et d'amélioration continue des parcours de soins.

AXES D'AMÉLIORATIONS

→ VALORISER LES APPORTS DE LA SOLUTION EN MATIÈRE D'EFFICIENCE ET DE PERFORMANCE

PLUS-VALUE ORGANISATIONNELLE

LES ENJEUX

Transformer la solution d'un simple outil de téléconsultation en modèle organisationnel structurant, reproductible et performant à l'échelle territoriale.

AXES D'AMÉLIORATIONS

→ ANTICIPER LES FREINS CULTURELS
→ FORMALISER UN MODÈLE ORGANISATIONNEL REPRODUCTIBLE
→ STRUCTURER L'ARTICULATION VISIO / PRÉSENTIEL POUR ARTICULER EFFICIENCE ET QUALITÉ CLINIQUE
→ OPTIMISER L'EFFICIENCE ORGANISATIONNELLE

CONTRIBUTION À LA CONSOLIDATION DES OUTILS ET PROCESSUS RÉGLEMENTAIRES

LES ENJEUX

Faire de la solution non seulement un outil clinique, mais un levier structurant de conformité réglementaire, de coordination pluridisciplinaire et de maturité organisationnelle

AXES D'AMÉLIORATIONS

→ CAPITALISER SUR L'IMPACT QUALITÉ ET CONFORMITÉ
→ RENFORCER LA COORDINATION MÉDICO-ÉDUCATIVE ET INSTITUTIONNELLE
→ CLARIFIER LE POSITIONNEMENT DU MÉDECIN COORDONNATEUR

10.4 IMPACTS SUR LA QUALITÉ ET LA CONTINUITÉ DES SOINS

PLUS-VALUE APPORTÉS PAR LA SOLUTION EN MATIÈRE DE QUALITÉ ET CONTINUITÉ DES SOINS

LES ENJEUX

La formalisation du modèle hybride, l'objectivation des résultats et la structuration du rôle du médecin référent doivent permettre :

- Une continuité des soins sécurisée
- Une coordination renforcée
- Une réduction des hospitalisations évitables
- Une maîtrise médico-économique
- Une démarche qualité pérenne et traçable
- Une résilience organisationnelle accrue

AXES D'AMÉLIORATIONS

→ CONSOLIDER ET FORMALISER LE MODÈLE HYBRIDE (VISIO + PRÉSENTIEL)
→ CAPITALISER SUR LA RÉDUCTION DES HOSPITALISATIONS ET DES COÛTS
→ FORMALISER LE RÔLE STRATÉGIQUE DU MÉDECIN RÉFÉRENT

LA SOLUTION COMME LEVIER DE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

LES ENJEUX

Valoriser la solution comme un véritable levier de transformation organisationnelle et de montée en compétence durable, au service de la qualité des soins.

AXES D'AMÉLIORATIONS

→ STRUCTURER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES ÉQUIPES
→ PROFESSIONNALISER LA GESTION DES SITUATIONS COMPLEXES
→ DÉVELOPPER LA MUTUALISATION TERRITORIALE DES COMPÉTENCES
→ CONSOLIDER LA CULTURE PLURIDISCIPLINAIRE

11. PLAN D’ACTION

PLAN D'ACTION : LES IMPACTS SUR L'ACCÈS À LA SANTÉ

INDICATEURS	AXES D'AMÉLIORATIONS	OBJECTIFS	ACTIONS À METTRE EN OEUVRE	ÉCHÉANCES	RESPONSABLE ET GROUPES DE TRAVAIL	SUIVI
Part des établissements en rupture de continuité de l'accès aux soins ayant obtenu une solution avec le dispositif.	**Affirmer le positionnement stratégique du dispositif.**	Renforcer le pilotage stratégique du dispositif grâce au suivi d'indicateurs d'impact et à leur valorisation dans les rapports d'activité des établissements.	**1/Produire et suivre des indicateurs d'impact quantitatifs :** Taux d'hospitalisations avant/après Délai moyen de renouvellement des ordonnances Nombre de bénéficiaires par secteurs Nombre d'actes réalisés / trimestre / an Données chiffrées venant renseigner les rapports d'activités des établissements et services			
	Structurer la mutualisation inter-établissements.	Renforcer la coopération inter-établissements afin de développer une offre territoriale mutualisée au service de la continuité des parcours de soins.	**1/ Développer une offre territoriale mutualisée** Planning mutualisé digitalisé Gestion centralisée des créneaux **2/ Positionner la solution comme réponse territoriale à la pénurie** En lien avec : la feuille de route du virage numérique en santé 2023-2026 les problématiques ARS sur la continuité des parcours			
Niveau d'adhésion des acteurs à la présentation de la solution au regard des besoins.	**Mieux accompagner les directions et gouvernances associatives.**	Appuyer la décision stratégique grâce à des outils de communication valorisant les impacts médico-économiques, organisationnels et réglementaires du dispositif.	**1/Élaborer des outils supports de communication qualité pour faciliter la décision stratégique** Arguments médico-économiques Impact sur la continuité des soins Réduction hospitalisations Conformité réglementaire			
	Structurer l'accompagnement au changement.	Faciliter l'appropriation et le déploiement du dispositif par les équipes grâce à des outils structurés, de la formation et un accompagnement dédié.	**1/Formaliser un kit de communication -Proposer un kit de déploiement « clé en main » :** Plan de pilotage type Feuille de route sur 6 mois RACI (qui fait quoi ?) Modèle de note d'organisation interne Clarification écrite des rôles (médecin coordonnateur / médecin traitant / IDE / psychologue) **2/Créer un parcours d'acculturation progressif** Webinaires d'introduction Modules courts e-learning pour les équipes Tutoriels "préparer une téléconsultation" Guide "comment créer la relation médecin-équipe à distance" **3/Désigner et former un référent interne obligatoire** **4/Former les équipes à la préparation clinique des séquences**			
	Renforcer la communication et l'adhésion des familles.	Renforcer l'adhésion des personnes accompagnées et de leurs familles en améliorant l'information et la compréhension du dispositif.	**1/Fournir des supports de communication prêts à l'emploi pour les personnes accompagnées et les familles** Vidéo de présentation du dispositif Fiche de présentation du médecin FAQ familles Modèle de courrier d'information Modèle de recueil de consentement simplifié **2/Proposer une « séquence de rencontre inaugurale »**			

PLAN D'ACTION : LES IMPACTS FONCTIONNELS

INDICATEURS	AXES D'AMÉLIORATIONS	OBJECTIFS	ACTIONS À METTRE EN OEUVRE	ÉCHÉANCES	RESPONSABLE ET GROUPES DE TRAVAIL	SUIVI
Niveau de facilité de prise en main des outils.	**Structurer la formation et l'appropriation des outils.**	Structurer un parcours de formation accessible et standardisé pour faciliter l'appropriation durable des outils numériques par les professionnels.	**1/Définir un parcours modulaire (plateforme, téléconsultation, objets connectés)** Module 1 : prise en main plateforme Module 2 : préparation d'une téléconsultation Module 3 : utilisation des objets connectés **2/Créer des formats courts et accessibles** Vidéos tutoriels 3–5 minutes Fiches réflexes imprimables QR code sur la mallette d'objets connectés Mini e-learning pour intérimaires **3/Automatiser la formation des nouveaux arrivants** Proposer : Un "kit nouvel utilisateur" Une session trimestrielle ouverte Une formation à la demande lors de turn-over important			
	Fluidifier l'intégration technique.	Sécuriser et fluidifier l'accès au dispositif en anticipant les prérequis techniques et organisationnels avant son déploiement.	**1/Formaliser un protocole d'accès anticipé** Avant démarrage : • Check-list informatique • Création anticipée des droits d'accès médecin • Coordination avec service informatique local			
	Simplifier l'expérience utilisateur.	Améliorer l'ergonomie et la prise en main de la plateforme afin de faciliter son utilisation par les professionnels.	**1/Renforcer l'ergonomie et l'intuitivité initiale Plateforme** Tableau de bord personnalisé par rôle Moins d'étapes pour lancer une visio Raccourci "consultation rapide" **2/ Mettre en place un Onboarding guidé intégré** Au premier usage : • Tutoriel interactif • Parcours pas-à-pas • Info-bulles contextuelles			
	Structurer l'accompagnement au changement.	Faciliter l'appropriation et le déploiement du dispositif par les équipes grâce à des outils structurés, de la formation et un accompagnement dédié.	**1/Formaliser un kit de communication -Proposer un kit de déploiement « clé en main » :** Plan de pilotage type Feuille de route sur 6 mois RACI (qui fait quoi ?) Modèle de note d'organisation interne Clarification écrite des rôles (médecin coordonnateur / médecin traitant / IDE / psychologue) **2/Créer un parcours d'acculturation progressif** Webinaires d'introduction Modules courts e-learning pour les équipes Tutoriels "préparer une téléconsultation" Guide "comment créer la relation médecin-équipe à distance" **3/Désigner et former un référent interne obligatoire** **4/Former les équipes à la préparation clinique des séquences**			

INDICATEURS	AXES D'AMÉLIORATIONS	OBJECTIFS	ACTIONS À METTRE EN OEUVRE	ÉCHÉANCES	RESPONSABLE ET GROUPES DE TRAVAIL	SUIVI
	Optimiser l'usage des objets connectés.	Optimiser l'utilisation des outils numériques et objets connectés pour renforcer la sécurité et l'efficacité des soins.	**1/Produire un guide "quand utiliser quel outil"** • Indications cliniques • Cas pratiques • Fiches pathologies fréquentes en ESMS **2/Valoriser l'impact clinique des objets connectés** • Réduction des hospitalisations • Sécurisation psychiatrique via ECG • Gain de temps diagnostic			
Niveau de satisfaction des réponses aux besoins techniques.	**Renforcer l'accompagnement organisationnel.**	Structurer et sécuriser le déploiement sur site en standardisant l'accompagnement et le suivi des installations.	**1/Formaliser une méthodologie d'installation in situ** • Audit organisationnel préalable • Check-list d'implantation • Planning type des 3 premiers mois • Points de suivi programmés **2/ Standardiser le rôle du responsable de zone** • Fréquence des points de suivi • Type d'accompagnement proposé • Indicateurs de réussite du déploiement			
	Anticiper les contraintes techniques locales.	Assurer la fiabilité technique des consultations en anticipant les contraintes et en prévoyant des procédures de secours.	**1/Audit technique pré-déploiement** • Qualité réseau • Compatibilité matérielle • Test connexion avant 1ère consultation **2/Guide "gestion des imprévus techniques"** • Procédure si coupure réseau • Plan B consultation • Contact support prioritaire			

PLAN D'ACTION : LES IMPACTS ORGANISATIONNELS

INDICATEURS	AXES D'AMÉLIORATIONS	OBJECTIFS	ACTIONS À METTRE EN OEUVRE	ÉCHÉANCES	RESPONSABLE ET GROUPES DE TRAVAIL	SUIVI
Niveau de couverture des besoins renforcée par la solution.	**Valoriser les apports de la solution en matière d'efficience et de performance.**	Évaluer et valoriser l'impact organisationnel et médico-économique du dispositif grâce à des indicateurs fiables et actualisés.	**1/Mesurer l'impact organisationnel médico-économique** • Nombre de déplacements évités pour les personnes accompagnées et les soignants **2/Produire des indicateurs organisationnels** • Délai renouvellement prescription • Taux hospitalisations évitées • Participation aux réunions pluridisciplinaires • Production et actualisation des outils supports cadres			
Part de plus-value organisationnelle apportée par la solution.	**Anticiper les freins culturels.**	Démontrer la valeur organisationnelle du dispositif en mettant en avant sa contribution à la structuration, la traçabilité et la clarification des processus.	**1/Développer un argumentaire "qualité organisationnelle"** Montrer que : • La visio structure davantage • Favorise l'anticipation et l'analyse croisée • Améliore la traçabilité • Clarifie les processus (évaluation – prescription – réévaluation)			
	Formaliser un modèle organisationnel reproductible.	Standardiser l'organisation des séquences cliniques pour faciliter la planification et la coordination des soins.	**1/Créer un "modèle organisationnel type"** Incluant : • Format type d'une séquence (brief – actes – débrief) • Gestion des renouvellements en fin de séance • Organisation des créneaux fixes • Modèle de réunion pluridisciplinaire avec médecin			
	Structurer l'articulation visio / présentiel pour articuler efficience et qualité clinique.	Structurer et uniformiser l'organisation des séquences cliniques pour améliorer la coordination et l'efficacité des soins.	**1/Formaliser un "parcours hybride"** • Visio régulière • Présentiel annuel ou semestriel • Présentiel stratégique pour cas complexes **2/Définir les indications du présentiel** • Situations complexes • Travail institutionnel (GIR, PATHOS, évaluation externe) • Travail sur protocoles			
	Optimiser l'efficience organisationnelle.	Assurer la continuité et l'efficacité des soins grâce à la priorisation des actes et à l'optimisation des remplacements médicaux.	**1/Développer une méthode de priorisation intégrée** • Inspiré des systèmes de codes couleurs évoqués. **2/ Optimiser les remplacements des médecins (congés, arrêts maladie)** • Créer une procédure interne garantissant la communication, la réactivité et la pertinence des périodes de remplacement en termes de priorisation des actes.			

INDICATEURS	AXES D'AMÉLIORATIONS	OBJECTIFS	ACTIONS À METTRE EN OEUVRE	ÉCHÉANCES	RESPONSABLE ET GROUPES DE TRAVAIL	SUIVI
Niveau de consolidation des outils et process référentiels réglementaires.	**Capitaliser sur l'impact qualité et conformité.**	Positionner la solution comme levier d'amélioration continue et de conformité réglementaire.	**1/Créer un module "Appui qualité" en lien avec le référentiel d'évaluation Haute Autorité de Santé comprenant :** • Check-list qualité alignée sur les attendus d'évaluation • Accompagnement à la formalisation et mise à jour des protocoles • Indicateurs prêts à valoriser lors des évaluations • Participation formalisée du médecin dans la démarche qualité			
	Renforcer la coordination médico-éducative et institutionnelle.	Encourager et formaliser la participation du médecin aux temps stratégiques.	**1/Encourager la participation du médecin aux réunions stratégiques** • Réunions pluridisciplinaires • Soutien direct aux équipes éducatives • Coordination kiné / ergo / psychomotricien (MPR) & psychiatre /psychologue • Admissions • Réorientations • Dossiers MDPH • Commissions gériatriques			
	Clarifier le positionnement du médecin coordonnateur.	Sécuriser le cadre d'intervention et clarifier l'articulation entre médecin traitant et médecin coordonnateur afin de sécuriser les responsabilités et la complémentarité des rôles.	**1/Formaliser une charte de mission précisant que le médecin** • Garant de la coordination médicale • Appui réglementaire • Appui clinique • Appui stratégique auprès de la direction			

PLAN D'ACTION : LES IMPACTS SUR LA QUALITÉ ET LA CONTINUITÉ DES SOINS

INDICATEURS	AXES D'AMÉLIORATIONS	OBJECTIFS	ACTIONS À METTRE EN OEUVRE	ÉCHÉANCES	RESPONSABLE ET GROUPES DE TRAVAIL	SUIVI
Part des éléments qualitatifs (plus-value) apportée par la solution en matière de qualité et continuité des soins.	**Consolider et formaliser le modèle hybride (visio + présentiel).**	Meilleure continuité médicale Meilleure coordination équipe/médecin Sécurisation des situations complexes Approche structurée de l'amélioration continue de la qualité	**1/Formaliser un "modèle hybride recommandé"** • 2 créneaux visio réguliers minimum • 1 à 2 journées de présentiel annuelles structurées • Indications précises du présentiel : ◦ situations complexes ◦ travail qualité ◦ GIR / PATHOS ◦ Plan Bleu ◦ analyse institutionnelle **2/Structurer les journées en présentiel** • Matin : coordination / qualité / protocoles • Après-midi : consultations ciblées			
	Capitaliser sur la réduction des hospitalisations et des coûts.	Pilotage objectif de la performance Valorisation médico-économique Renforcement du dialogue avec les tutelles Amélioration continue documentée	**1/Déployer des indicateurs standardisés** • Taux d'hospitalisation avant/après • Nombre de passages aux urgences • Évolution budget pharmacie • Délai de renouvellement prescription • Taux de prescriptions réévaluées • Recherche d'approches non médicamenteuses **2/Produire un rapport annuel qualité & continuité des soins** Co-signé avec le médecin référent.			
	Formaliser le rôle stratégique du médecin référent.	Sécurisation des transitions Réduction du risque de rupture de soins Stabilisation des équipes Vision stratégique renforcée	**1/Rédiger une charte du médecin référent** Incluant : • Continuité des soins • Coordination territoriale • Soutien qualité • Participation aux réunions clés • Rôle en prévention **2/Anticiper la continuité en cas de changement de médecin ou remplacement** • Transmission formalisée • Dossier organisationnel partagé • Communication établissements et services (information organisation, présentation du médecin) • Communication nouveau médecin (information établissement)			
Nombre de professionnels ayant développé leurs compétences dans le cadre de la mise en place de la solution.	**Structurer le développement des compétences des équipes.**	Promouvoir le renforcement du raisonnement clinique des équipes L'approfondissement des compétences en gériatrie Le positionnement de la solution comme outil de montée en compétence institutionnelle	**1/Formaliser un programme de formation continue avec le médecin** • Sessions de raisonnement clinique • Analyse de situations complexes • Approches non médicamenteuses • Prévention (chutes, canicule, vaccination) **2/Proposer un format "revue de cas trimestrielle"** Capitaliser sur les situations complexes encore peu exploitées. Positionner la solution comme levier de montée en compétence institutionnelle.			

INDICATEURS	AXES D'AMÉLIORATIONS	OBJECTIFS	ACTIONS À METTRE EN OEUVRE	ÉCHÉANCES	RESPONSABLE ET GROUPES DE TRAVAIL	SUIVI
	Professionnaliser la gestion des situations complexes	Développement d'une expertise collective Meilleure anticipation des risques Sécurisation des décisions cliniques	Un protocole dédié "situations complexes" Identification des situations à fort enjeu Préparation en amont Séquence dédiée avec le médecin Synthèse écrite et plan d'action formalisé			
	Optimiser la préparation des téléconsultations	Amélioration de la qualité des échanges Développement de l'autonomie clinique meilleure pertinence des décisions médicales	Développer une trame standard intégrée à la plateforme Motif Données cliniques clés Hypothèses Traitement en cours Question précise au médecin			
	Développer la mutualisation territoriale des compétences	Enrichissement mutuel des équipes, Réduction des disparités de pratiques, Création d'une dynamique territoriale apprenante pour que la solution devienne un outil de coopération inter-établissements	**1/Développer un modèle territorial multi-établissements** • Planning mutualisé • Coordination inter-services			
	Consolider la culture pluridisciplinaire	Renforcement du travail en équipe, Meilleure coordination soignants/médecin Approche globale et partagée des situations	**1/Formaliser un modèle de réunion clinique type** • Ordre du jour structuré • Temps d'analyse • Synthèse écrite • Plan d'action partagé			

PLAN D'ACTION SYNTHÉTIQUE

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

MESURER

RENFORCER NOTRE STRATÉGIE DE PILOTAGE

Faire du dispositif un outil de communication et d'aide à la décision
Suivi d'indicateurs d'impact
Production de rapports d'activité et qualité
Valorisation médico-économique et réglementaire
Positionnement comme réponse territoriale à la pénurie médicale

STRUCTURER

CONSOLIDER NOTRE ORGANISATION

Développer la performance et la pérennisation du dispositif
Standardisation des process internes et externes
Modèles organisationnels types (établissements)
Promotion de la mutualisation territoriale
Développement de la plateforme
Intégration dans les démarches qualité

COMMUNIQUER

DÉVELOPPER L'ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Garantir l'adhésion et la qualité d'usage
Parcours de formation modulable
Kit de déploiement et conduite du changement
Développement des compétences, renforcement de la culture pluridisciplinaire
Implication des bénéficiaires et de leur entourage